RELATION SOIGNANT-SOIGNÉ ET ÉCOUTE ACTIVE

UE D1.1 — Savoir-être, communication et leadership

FIL CONDUCTEUR

Une personne exprime une inquiétude : accueillir sa parole sans deviner ses pensées, comprendre son besoin relationnel, adopter une attitude d'écoute et proposer des ressources avec elle.

Objectifs annoncés par l'enseignante

- Identifier un **besoin relationnel** dans une situation de soin.
- Définir le **soin relationnel** et la relation d'aide.
- Reconnaître les **six attitudes de Porter** dans les réponses du soignant.
- Comprendre l'**écoute active** et savoir la mobiliser.
- Analyser la manière de répondre et la posture professionnelle.

Priorités déduites de la pratique

- Différencier **question ouverte**, enquête orientée et question fermée.
- Savoir **reformuler et clarifier** sans interpréter.
- Identifier les composantes non verbales, paraverbales et les limites émotionnelles du soignant.

À RETENIR

Les deux transcriptions constituent les sources de ce support. Elles se terminent chacune par des échanges de clôture ; le diaporama annoncé par l'enseignante n'est pas fourni. Le niveau de détail des diapos n'a donc pas été vérifié.

01 Communication adaptée et congruence

Communiquer de manière adaptée ne signifie pas seulement « donner les bonnes informations ». La séance rappelle la cohérence entre les **paroles et le non-verbal**, l'écoute des besoins et des demandes, ainsi que l'adaptation au niveau de compréhension et à la disponibilité psychique du patient.

Repère	Concrètement
Congruence	Alignement entre ce que le soignant pense, dit et fait.
Compréhension	S'assurer que l'autre peut recevoir et comprendre l'information.
Disponibilité	Adapter sa posture, sa place, son regard et son rythme.
Prise en compte du vécu	Ne pas substituer le discours du professionnel à ce que la personne exprime.

À RETENIR

Dire « je vous écoute » ne suffit pas si l'attitude corporelle manifeste l'inverse. La congruence est une cohérence observable.

02 Identifier le besoin relationnel

L’enseignante le définit comme un **besoin d’entrer ou de rester en relation avec l’autre** pour exprimer, partager, comprendre ou traverser ce que l’on vit. Un soin techniquement programmé peut devenir le moment où ce besoin se révèle.

Situation travaillée

Une patiente de **45 ans**, à **J5 d’une mastectomie gauche** réalisée après un cancer du sein, exprime son inquiétude alors qu’un étudiant vient pour un soin. Sa phrase ne permet pas de savoir ce qui l’inquiète précisément : image corporelle, avenir, famille ou autre. Ces causes seraient des hypothèses, pas des faits.

> **Bon réflexe**
>
> « Vous dites que cela vous inquiète. Qu’est-ce qui vous inquiète plus particulièrement ? »

Le rôle relationnel n’impose pas de suspendre systématiquement un geste : on peut prendre un temps d’écoute, aménager le soin, prévoir un retour réaliste ou solliciter un relais pertinent, en respectant la situation.

03 Soin relationnel : du besoin à la réponse

Le **soin relationnel** est un accompagnement qui permet à la personne d’exprimer son vécu, ses émotions, ses représentations et ses besoins. Il s’articule aux soins techniques. La réponse n’est pas forcément une solution immédiate : permettre de parler est déjà un acte professionnel.

Ce que fait le soignant	Risque / intérêt
Accueille le propos et vérifie le sens	Reconnaît la demande réelle sans projeter son vécu.
Laisse la personne préciser	Favorise son expression et son pouvoir de décision.
Répond trop vite	Peut fermer l’échange ou minimiser le vécu.
N’a pas le temps immédiatement	Peut organiser une nouvelle disponibilité ou un relais avec l’équipe.

Méthode de réponse

Observer → reconnaître l’émotion exprimée → reformuler → questionner ouvertement → rechercher avec la personne une aide adaptée.

04 Les six attitudes de Porter

La grille des **six attitudes** sert à reconnaître la manière dont le soignant répond et l'effet possible de cette réponse sur l'espace de parole. L'enseignante insiste pour apprendre à **identifier les attitudes**, sans les transformer en interdictions absolues hors contexte.

Attitude	Exemple et effet possible
1. Évaluation / jugement	« Vous devez être forte » : appréciation pouvant culpabiliser.
2. Interprétation	« Vous avez sûrement peur de ne plus plaire » : cause supposée.
3. Soutien / réassurance	« Tout va bien se passer » : peut rassurer trop tôt sans preuve.
4. Investigation / enquête	« Est-ce le travail, les enfants ou le conjoint ? » : hypothèses imposées.
5. Solution / conseil	« Vous devriez consulter… » : proposition décidée par le soignant.
6. Compréhension	« Vous vous demandez comment vivre ce changement » : reprend le vécu exprimé.

À RETENIR

Les paroles changent d'effet selon le moment, la formulation et le vécu de la personne. La compréhension laisse de la place au récit ; les autres attitudes peuvent la réduire si elles interviennent trop tôt.

05 Reconnaître les réponses qui ferment le dialogue

L’enseignante montre notamment qu’une **bonne intention** ne garantit pas une **bonne réception** par la personne. La fausse réassurance ou le jugement ont parfois pour effet de minimiser l’inquiétude.

Réponse spontanée	Ce qui pose problème et alternative
« Soyez positive »	Peut laisser entendre que la personne réagit mal. Reconnaître d’abord l’inquiétude.
« Je sais ce que vous ressentez »	Suppose un vécu identique. Demander comment elle vit l’événement.
« Ce qui vous inquiète, c’est votre conjoint »	Interprétation : vérifier au lieu d’attribuer.
« Vous devriez faire ceci »	Conseil rapide : explorer les ressources et les souhaits.
« Ne vous inquiétez pas »	Réassurance incertaine : être présent sans promettre l’issue.

Piège de raisonnement

Ne jamais présenter une hypothèse du professionnel comme une émotion ou une priorité certaine du patient.

06 Carl Rogers et les trois attitudes de l’écoute active

L’écoute active est une **posture physique et intellectuelle**. La séance rattache à Carl Rogers trois composantes complémentaires :

Composante	Définition appliquée au soin
Empathie	Chercher à comprendre le monde de l’autre sans se confondre avec lui ou vivre nécessairement les mêmes émotions.
Considération positive inconditionnelle	Reconnaître la valeur, les capacités et les ressources de la personne, indépendamment de sa réponse.
Congruence	Alignement entre ce que le professionnel pense, dit et fait.

Empathie ≠ sympathie

La séance distingue une **compréhension professionnelle** du vécu de l’autre de la **proximité amicale** de la sympathie. Être empathique n’impose pas de se perdre dans ses propres émotions ; garder une posture chaleureuse ne signifie pas devenir l’ami du patient.

À RETENIR

La relation aide la personne à retrouver ou mobiliser ses ressources, et non à exécuter la solution choisie par le soignant.

07 Les techniques de l’entretien

Technique	Utilité et exemple
Question ouverte	Explore le vécu : « Qu’est-ce qui vous inquiète davantage ? »
Question fermée	Utile pour une information précise ou une réponse oui/non ; ne remplace pas l’expression libre.
Reformulation	Reprendre avec fidélité les mots : « Vous dites ne pas savoir comment vivre ainsi ».
Clarification	Faire préciser le sens : « Que signifie pour vous “comme avant” ? »
Silence	Laisser du temps pour réfléchir, ressentir et poursuivre le récit.
Valorisation	Reconnaître une capacité ou une ressource réelle, sans compliment automatique.

Pourquoi reformuler ?

La reformulation aide à **vérifier ce qui a été compris**. Le patient peut confirmer, nuancer ou corriger. La séance mentionne plusieurs formes de reformulation, notamment clarification et recadrage ; leur emploi reste lié au contexte et à l’objectif de compréhension.

À RETENIR

Questionner, reformuler, encourager et faciliter la parole rendent l’écoute réellement active. Un silence n’est pas automatiquement un refus.

08 Le corps, la voix et le toucher dans la relation

La communication implique aussi les manifestations qui accompagnent ou remplacent les mots. Observer n’autorise pas à attribuer un état psychologique certain à partir d’un seul signe.

Canal	Repères évoqués
Verbal	Contenu des mots, type de question et reformulation.
Paraverbal	Voix, timbre, intensité, débit, rythme, silences.
Non verbal	Regard, position corporelle, distance, mimiques, éventuel toucher.
Toucher empathique	Contact de soutien relationnel, seulement adapté et accepté.
Toucher gnosique	Contact servant à recueillir des signes ou informations cliniques.

À RETENIR

Pour rester congruent, adapter la posture, le regard et la voix à la personne et à sa situation. Ne pas imposer le toucher ; tenir compte de son accord.

09 Les émotions du soignant et la distance relationnelle

Une situation peut provoquer **tristesse, malaise, stress, sentiment d'impuissance** ou peur de mal répondre. Le professionnel n'a pas à prétendre qu'il n'éprouve rien, mais doit reconnaître ces réactions et éviter qu'elles dirigent l'entretien.

Réflexe	Conséquence
Repérer ce qui résonne avec son histoire	Éviter de confondre sa propre émotion avec celle du patient.
Canaliser son émotion	Rester professionnel, disponible et respectueux.
Reconnaître l'altérité	La personne a ses valeurs, croyances et réactions propres.
Relayer si nécessaire	Passer la main lorsque l'intensité émotionnelle compromet l'écoute.
S'appuyer sur l'équipe	Partager les éléments utiles au soin selon les règles de confidentialité.

À RETENIR

La bonne distance ne signifie ni froideur ni familiarité : elle permet d'accompagner sans se laisser submerger et sans imposer son vécu.

10 Situation intégratrice : après une mastectomie

Le cas de la patiente à J5 d'une mastectomie est repris en fin de séance. L'objectif est de construire une réponse professionnelle centrée sur elle, plutôt que d'inventer une explication à ses mots.

Étape	Exemple concret
1. Accueillir	S'arrêter quand c'est possible, posture calme, regard attentif.
2. Reconnaître	« J'entends que cette situation vous inquiète. »
3. Reformuler	« Vous vous demandez comment vivre ce changement. »
4. Explorer	« Qu'est-ce qui vous inquiète plus particulièrement ? »
5. Accompagner	Chercher avec elle ressources personnelles, entourage, équipe ou autre relais adapté.
6. Adapter	Tenir compte de son accord, du soin en cours et de son rythme.

Ce qu'il faut éviter

• Supposer que sa préoccupation concerne nécessairement son apparence, sa sexualité ou sa famille.

• Promettre une évolution favorable sans l'avoir évaluée.

• Abandonner le besoin relationnel à un autre professionnel sans avoir accueilli la parole.

11 Transmissions et ressources possibles

La relation d’aide ne repose pas sur une seule personne. L’enseignante évoque les échanges avec l’équipe soignante, le médecin, d’autres professionnels, les proches lorsque la personne le souhaite, ainsi que d’éventuelles associations ou ressources de soutien.

Question pratique	Piste de réponse
Que veut la personne ?	Explorer ses priorités avant de proposer une orientation.
Quelles ressources possède-t-elle ?	Repérer capacités, entourage, activité et stratégies déjà utilisées.
Quel relais proposer ?	S’appuyer sur l’équipe, sans renvoyer immédiatement toute difficulté ailleurs.
Que transmettre ?	Les faits et besoins utiles au suivi, dans le cadre professionnel approprié.

À RETENIR

L’orientation est une **proposition** à discuter avec la personne et non une prescription relationnelle immédiate.

12 Pièges QCM / confusions à éviter

Confusion fréquente	Distinction correcte
Empathie = sympathie	Comprendre sans se confondre ni imposer une relation amicale.
Soutenir = promettre	Écouter et soutenir sans garantir « tout ira bien ».
Question ouverte = liste d'hypothèses	Une question ouverte ne propose pas la réponse à la place de l'autre.
Reformuler = interpréter	La reformulation vérifie le sens ; l'interprétation en ajoute un sans preuve.
Silence = échec	Le silence peut laisser du temps et une place au récit.
Soin technique ≠ écoute	Les deux dimensions peuvent se conjuguer.
Distance = froideur	Rester présent tout en régulant ses propres émotions.

À retenir pour les partiels

• Les **six attitudes de Porter** doivent être reconnues en situation : évaluation, interprétation, soutien, enquête, solution et compréhension.

• Les **trois repères de Rogers** : empathie, considération positive inconditionnelle, congruence.

• La **parole du patient** doit rester la référence : éviter les hypothèses transformées en certitudes.

13 Synthèse générale — l’essentiel du cours

Le cours part d’un besoin relationnel identifié en situation de soin, puis montre comment adopter une posture d’écoute adaptée. L’écoute est **active** car elle mobilise disponibilité, questions ouvertes, reformulation, clarification et respect du silence. Elle suppose un alignement entre parole et attitude, appelé congruence.

Les six attitudes de Porter aident à reconnaître les risques du jugement, de l’interprétation, de la réassurance hâtive, de l’enquête orientée et du conseil immédiat. Une attitude de compréhension ouvre davantage la possibilité d’exprimer un vécu.

Avec Carl Rogers, les repères essentiels sont l’empathie, la considération positive inconditionnelle et la congruence. La personne reste l’actrice de son parcours. Ses ressources, ses priorités et ses choix doivent être recherchés avant de proposer un accompagnement.

MÉMO DE RÉVISION

ACCUEILLIR → ÉCOUTER → REFORMULER → EXPLORER → RESPECTER → ACCOMPAGNER.

14 Définitions et mots-clés

Terme	Définition de révision
Besoin relationnel	Besoin d’entrer ou de rester en relation pour partager et comprendre ce que l’on vit.
Soin relationnel	Accompagnement qui permet à la personne d’exprimer son vécu et d’être entendue.
Écoute active	Posture disponible et attentive qui mobilise l’écoute, la reformulation et le questionnement adapté.
Congruence	Accord entre pensées, paroles, attitudes et actes.
Empathie	Compréhension du monde de l’autre sans confusion avec sa propre histoire émotionnelle.
Considération positive inconditionnelle	Reconnaissance de la valeur et des ressources de la personne sans jugement conditionnel.
Attitudes de Porter	Six types de réponses : évaluation, interprétation, soutien, investigation, solution, compréhension.
Évaluation / jugement	Appréciation sur la façon dont la personne devrait réagir.
Interprétation	Attribution d’un motif ou d’un sens non formulé par la personne.
Soutien / réassurance	Tentative de réconfort pouvant parfois minimiser l’inquiétude.
Investigation / enquête	Exploration dirigée par les hypothèses du soignant.
Conseil / solution	Proposition de conduite à tenir formulée par le soignant.
Compréhension	Réponse qui reconnaît et reformule le vécu exprimé.
Question ouverte	Question laissant la personne développer librement son point de vue.
Question fermée	Question qui appelle une réponse limitée et précise.
Reformulation	Reprise du message pour vérifier et clarifier sa compréhension.

Terme	Définition de révision
Clarification	Demande de précision sur un mot ou une idée ambiguë.
Paraverbal	Intensité, rythme, débit et timbre de la voix, pauses.
Non verbal	Regard, posture, distance, mimiques et autres signes corporels.
Proxémie	Ajustement de la distance corporelle entre les personnes.
Toucher empathique	Toucher exprimant une présence ou un soutien dans une relation adaptée.
Toucher gnosique	Toucher visant la recherche d’informations ou de signes cliniques.
Distance relationnelle	Position professionnelle qui associe proximité humaine et régulation de ses propres émotions.
Altérité	Reconnaissance de l’autre comme une personne ayant ses propres valeurs et représentations.
Mastectomie	Ablation chirurgicale d’un sein ; élément du cas clinique étudié.